PETJOURNEY · PORTAL DO PARCEIRO

Módulo clínico — relatório de novidades

Orientação do fluxo, alta hospitalar e os defeitos encontrados no caminho.

Data: 9 de setembro de 2026 **Ramo:** develop **Escopo:** `src/features/clinico`, menu do portal

Natureza: protótipo navegável, sem API

Em uma página

O ponto de partida foi uma reclamação: **o fluxo clínico está confuso**. A auditoria não encontrou tela faltando nem tela sobrando. Encontrou uma **lista plana de dez destinos**, todos aparentemente vazios, sem nenhuma indicação de qual responde à pergunta do momento — e nenhuma forma de chegar a um paciente sem antes adivinhar em qual das quatro listas ele está agora.

Ao percorrer o módulo inteiro atrás disso, apareceu algo maior: a **alta hospitalar não tinha tela**. O motor existia no repositório desde o primeiro dia e nenhuma tela o chamava — o animal entrava no mapa de leitos e não tinha por onde sair. O protótipo demonstrava metade de um ciclo e parava exatamente onde a clínica precisa registrar o que aconteceu.

Nada foi removido. Os dez destinos continuam os dez, com os mesmos nomes e as mesmas rotas; o que mudou é que a lista deixou de exigir leitura inteira, o menu passou a dizer onde está o trabalho, e a internação deixou de ser um sistema paralelo.

691	**+30**	**3**	**62**
testes passando (eram 661)	testes novos, em 59 arquivos	defeitos encontrados e corrigidos	chaves novas, nos 4 idiomas

> **A régua que orientou cada decisão**
>
> Nada foi retirado do que já existia. Toda mudança ou **encurta um caminho** que a clínica já percorria, ou **fecha um ciclo** que começava e não terminava. Onde havia dúvida entre travar e avisar, a escolha foi avisar: regra que impede o registro da verdade não protege ninguém — produz um sistema que a clínica contorna no papel.

Parte 1 · Orientação — a resposta à reclamação

1.1 O menu agora diz onde está o trabalho

ANTES

Dez destinos, todos com a mesma aparência. Para saber se havia alguém na fila, uma dose atrasada ou um rascunho sem fecho, era preciso **abrir as dez telas** e conferir uma a uma. Quem opera a clínica fazia essa ronda várias vezes por dia.

AGORA

Cada tela com trabalho parado carrega um selo com o número. Fila, Internação, Atividades e Vacinas. A ronda das dez telas virou um olhar para a coluna.

AS REGRAS DO SELO

- **Só conta o que alguém precisa fazer.** "38 atendimentos hoje" não é pendência, é rotina; "2 doses atrasadas" é. Um contador que soma rotina ensina a ignorar contador — e aí ele para de funcionar no dia em que o número importa.
- **Cada número aparece em um lugar só.** O rascunho de prontuário é pendência de *Atividades* e não também de *Prontuários*: o mesmo trabalho contado duas vezes faz a clínica procurar duas vezes e achar uma.
- **Zero não vira selo.** Um "0" em cada linha é ruído que ensina a não olhar.
- **Três tons, e cada um sobe um canal além da cor.** Em escala de cinza, ou para quem não distingue vermelho de âmbar, a diferença entre "há gente na fila" e "há um boletim preso" continua de pé. O número nunca fica sozinho para o leitor de tela: a frase que o explica é **por tela**, porque "3" ao lado de Fila e "3" ao lado de Vacinas são três coisas diferentes.

1.2 Os dez destinos viraram quatro perguntas

A ordem anterior era a de construção — Meu dia, Resumo, Agenda, Prontuários, Fila, Internação, Faltas, Vacinas, Atividades. Ordem de construção não é ordem de uso: o Resumo, que se olha na segunda de manhã uma vez por semana, ficava em segundo lugar, acima da Agenda.

BLOCO	A PERGUNTA QUE ELE RESPONDE	TELAS
Agora	O que está acontecendo neste minuto, e onde cabe mais alguém	Meu dia · Agenda · Fila de espera
Em curso	O trabalho aberto que atravessa o dia	Prontuários · Internação
Pendências	O que ficou para trás e envelhece calado	Atividades · Faltas · Vacinas
Análise	O que só faz sentido olhar depois que o dia acabou	Resumo

O rótulo do bloco também é termo de busca: quem digita "pendências" no filtro do menu recebe as três telas do bloco, mesmo que nenhuma delas se chame assim.

1.3 Busca global — `Ctrl / ⌘ + K`

ANTES	AGORA
Para chegar ao Bento era preciso saber *por onde* se chega ao Bento: Pacientes se veio ontem, Internação se está no leito, Agenda se tem horário hoje, Prontuários se ficou em rascunho. Quem opera a clínica sabe o nome do animal — quase nunca sabe em qual das quatro listas ele está.	Digita-se o que se sabe — nome do animal, nome de quem responde por ele, telefone, ou o nome da tela — e a resposta é o destino. De qualquer tela, sem tirar as mãos do teclado.

- **Telas e pacientes na mesma lista, telas primeiro.** Separar em abas obrigaria a escolher antes de procurar — exatamente a escolha que quem está perdido não consegue fazer.
- **Abre mostrando as telas, sem digitar nada.** Uma paleta vazia é uma pergunta feita a quem não sabe a resposta. Com a lista à vista, ela também é o mapa do módulo — e é assim que ela ensina o menu a quem chegou hoje.
- **O atalho atravessa campo de texto.** É a única tecla do portal que precisa funcionar *enquanto* alguém digita: quem está no meio de uma anamnese e precisa conferir o histórico não vai clicar fora antes. Não colide com os atalhos de uma letra da agenda.
- **O paciente carrega o que o identifica.** Há dois "Mel" no cadastro, e é o nome de quem responde por eles que os separa. Quem escolhe errado no balcão abre o prontuário errado.

1.4 A internação deixou de ser um sistema paralelo

Um veterinário com cinco animais internados abria a landing do próprio perfil e não via nenhum deles. O portal parecia dois sistemas: o das consultas, que "Meu dia" resumia, e o da internação, que só existia para quem lembrasse de abrir o mapa de leitos.

- **"Meu dia" ganhou o bloco *Internados que cobram você*** — só quem tem dose atrasada ou boletim preso, nunca a lista inteira. Quem quer a lista tem o mapa; quem abre a landing às oito da manhã quer saber o que não pode esperar.
- **O boletim retido subiu para o topo de "Meu dia", como botão.** No mapa ele é texto — quem está lá já chegou ao lugar onde se resolve. Três telas antes, um aviso que diz "ligue para alguém" sem levar a lugar nenhum transfere para quem lê o trabalho de descobrir onde é esse lugar.
- **O histórico do paciente sabe que ele está internado agora**, e leva ao leito. Era a página mais completa que a clínica tem sobre um animal, e a única que não sabia que ele estava internado ali dentro.
- **A internação deixou de ser um beco:** do leito se chega ao histórico do paciente sem passar pelo menu.

Parte 2 · Internação — o ciclo que agora fecha

> **O que estava faltando**
>
> `internacaoRepository.darAlta` existia desde o primeiro dia e **nenhuma tela o chamava**. O animal entrava no mapa de leitos e não tinha por onde sair: internar, medicar, evoluir e comunicar funcionavam; encerrar, não. Além do registro que ficava por fazer, o mapa de leitos perdia o sentido — leito ocupado por um animal que foi para casa é uma vaga que a clínica não sabe que tem.

2.1 Três desfechos, e não dois

Alta, **transferência** e **óbito**. A transferência é o caso que costuma sumir dos sistemas: o animal saiu vivo e o caso continua em outro lugar. Somá-la à alta faria a clínica ler como sucesso um encaminhamento às três da manhã para um centro de referência; somá-la ao óbito seria pior.

REGRA DE SERVIDOR **Óbito e transferência não saem por mensagem.**

É a mesma regra do boletim de piora, aplicada ao outro extremo da internação: notícia grave não chega por notificação. As duas exigem o registro da ligação, e o repositório recusa o encerramento sem ele — `AltaSemAvisoError`. A regra mora lá, e não na tela, pelo motivo de sempre: tela se contorna, e uma rota de API amanhã contornaria sozinha.

2.2 A última mensagem ao responsável

A conversa do aplicativo terminava no boletim das 14h, e quem estava do outro lado ficava com o celular na mão num sábado à noite sem saber se já podia parar de olhar. A alta agora escreve a mensagem que fecha o ciclo que os boletins abriram: o animal foi para casa, quanto tempo ficou, e o que fazer agora.

Ela nasce **liberada**, e não retida. O compositor comum decide a retenção pela gravidade — e um animal que passou a internação inteira crítico e teve alta cairia como notícia grave, preso esperando uma ligação que ninguém precisa dar.

2.3 A conferência de última hora

Antes de confirmar, o diálogo mostra o que fica para trás: permanência, doses dadas, recusadas ou puladas, boletins entregues — e avisa sobre dose pendente agora, dose futura que será suspensa e boletim que nunca saiu.

> **São avisos, e nunca travas**
>
> A tentação de bloquear é grande e está errada. Um animal pode ir para casa com a dose das 18h no bolso do responsável, e um óbito acontece com um boletim retido na fila. Travar não faz a clínica resolver a pendência: faz o animal sair pela porta enquanto o sistema segue dizendo que ele está no leito R3 — e é assim que um mapa de leitos deixa de ser confiável.

- **A orientação é obrigatória nos três desfechos.** Na alta ela é o que o responsável vai ler e seguir em casa. No óbito e na transferência é o registro do que foi dito ao telefone — a única linha que responde, seis meses

depois, ao que exatamente foi comunicado e por quem.

- **Encerrar fica na migalha, não junto das abas.** As quatro abas são o trabalho do turno, que se repete a cada meia hora; a alta acontece uma vez e não se desfaz. Na mesma fileira, as duas coisas convidariam ao clique errado no fim de um plantão de doze horas.
- **A internação encerrada continua alcançável** — pelo link que alguém mandou, pelo histórico, pela auditoria de seis meses depois — e diz que está encerrada na primeira linha. Prescrever some; a lista inteira continua legível. Registro fechado se lê, não se continua.
- **A faixa de encerramento é neutra nos três desfechos.** Verde de sucesso na linha que diz que o animal morreu seria a pior escolha possível de paleta.

2.4 O boletim retido ganhou dono

O mapa contava os retidos num total no topo — "1 boletim retido" — e esse total não dizia **de quem**. Achar o paciente custava abrir os cinco internados um a um, que é exatamente a busca que um boletim retido não tem tempo de esperar. Agora o selo está no cartão do leito, com ícone de telefone e não de alerta: o que se pede ali não é atenção, é uma ligação.

O selo do boletim é cheio e o do atraso é contornado. Os dois podem aparecer no mesmo cartão, e com a mesma marcação o olho os leria como duas linhas da mesma coisa. São dois pedidos diferentes: o atraso chama a enfermagem, que está no corredor; o boletim chama alguém para pegar o telefone.

Parte 3 · Defeitos encontrados no caminho

Nenhum dos três foi procurado. Os três apareceram porque a revisão passou por código que ninguém tinha motivo para reler.

D1 · A seção clínica se chamava "clinico.modulo"

O rótulo da seção mais usada do portal — no trilho lateral e no cabeçalho de toda página clínica — vinha de `t('clinico.modulo')`. A chave existe, mas resolve para um **objeto**: as duas frases do interruptor do módulo. O `vue-i18n` devolve o próprio caminho quando não encontra texto, e a seção se anunciava com um caminho de código.

Passou por revisão de tipos, build e testes porque nenhum dos três olha para o *valor* da chave. O teste que pegaria isto já existe no projeto — a asserção "não usa como texto nada que seja um grupo" — mas varre apenas os arquivos da internação. **Corrigido** com uma chave de texto própria.

D2 · A busca de pacientes não filtrava

A comparação por telefone era `telefone.replace(/\D/g,'').includes(termo.replace(/\D/g,''))`. Um termo **sem nenhum dígito** vira string vazia, e qualquer texto contém string vazia: buscar "Rita" casava com o telefone de todo mundo e devolvia o cadastro inteiro.

O defeito era invisível justamente porque não perdia nada — o paciente procurado estava sempre na lista, junto de outros vinte e três, ordenados por nome. Quem usava concluía que a busca era ruim, não que estava quebrada. Foi encontrado ao escrever o teste da busca global, que esperava zero resultados para um termo inventado. **Corrigido**, e agora coberto por seis testes.

D3 · Um byte nulo dentro de um arquivo de teste

Uma asserção de `render.spec.ts` carregava um NUL cru na fonte. Fazia o `grep` tratar o arquivo como binário, e a guarda não afirmava coisa alguma. **Corrigido** pela asserção que ela pretendia ser.

Ainda aberto, e fora deste escopo

Dois arquivos de teste que já estavam no ramo violam uma regra do `oxlint` (`expect` com argumento extra) e fazem `npm run lint` falhar. São anteriores a este trabalho e não foram tocados — mexer em testes alheios ao escopo é exatamente o tipo de mudança que se confunde com a mudança que se queria revisar.

Parte 4 · O que recomendo a seguir

O que a auditoria encontrou e **não** foi construído, em ordem de quanto custa a ausência.

PRIORIDADE	O QUÊ	POR QUÊ
ALTA	**Consentimento na agenda, quando o tipo é cirurgia**	O termo é assinado *antes* do procedimento e hoje só existe para reimpressão no fim. É o último buraco conhecido do percurso de demonstração — e, na operação real, é o documento cuja ausência aparece só quando já houve um problema.
ALTA	**Resumo de alta imprimível**	A alta já registra a orientação e manda a mensagem ao responsável. Falta o papel que vai junto com o animal — o mesmo caminho que a receita e o atestado já têm.
MÉDIA	**Alerta de medicação contínua no cabeçalho do paciente**	Já previsto na fundação visual (F6) e ainda não construído. É o alerta que muda conduta antes de a consulta começar, e o cruzamento com o bulário é o que evita a interação medicamentosa que ninguém lembrou de checar.
MÉDIA	**Estados de carga dentro dos componentes clínicos**	Carregando, vazio e erro moram na página de referência, e não nos componentes (F4/F5). Enquanto isso, cada tela nova reinventa os quatro estados — e alguma esquece um.
MÉDIA	**A internação encerrada na linha do tempo do paciente**	A internação em curso já entra no histórico. A encerrada precisa entrar com o desfecho e a permanência: são três dias de tratamento que, hoje, saem do registro quando o animal vai para casa.
BAIXA	**A busca global alcançar atendimentos e internações abertas**	Hoje ela leva a telas e pacientes. Buscar por "Bento" e receber também o rascunho de prontuário dele encurtaria mais um caminho — mas o caminho já é curto pelo paciente.
BAIXA	**Selos de pendência também no trilho recolhido**	Com o menu recolhido, o trabalho parado volta a ficar invisível. Um ponto no ícone da seção resolveria — vale medir se alguém opera recolhido antes de construir.

> **Gate de processo, não entregável de código**
>
> Os quatro rótulos do menu — Agora, Em curso, Pendências, Análise — são as quatro perguntas que *nós* achamos que a clínica faz. Antes de tratá-los como assentados, vale uma rodada de vinte minutos com alguém que opera clínica de verdade, olhando o menu e dizendo em voz alta o que procura. É a única verificação deste relatório que não pode ser feita por teste automatizado.

Verificação desta rodada

Testes unitários	**691 passando, 59 arquivos**	Verificação de tipos	`vue-tsc` **limpo**
Build de produção	**gerado sem erro**	Paridade de i18n	**4 idiomas, sem divergência**
Lint dos arquivos tocados	**limpo (oxlint + eslint)**	Formatação	**Prettier aplicado**

CUIDADO COM O TAMANHO DO PACOTE

Duas peças novas são lidas pelo menu do portal, que existe para **toda** conta — inclusive as que não têm o módulo clínico. Tanto a contagem de pendências quanto a busca global carregam a camada de dados clínicos **sob demanda**, e não no topo do arquivo: um `import` estático arrastaria o dataset inteiro de demonstração para o primeiro carregamento de todo mundo, para calcular quatro números que a maioria das contas nunca vê. O build confirma: a camada de dados continua num pedaço próprio.

Documentação técnica correspondente: `docs/clinico/08-orientacao-do-fluxo.md` (orientação, com os três defeitos detalhados) e `docs/clinico/07-internacao.md` (alta hospitalar). O roteiro de demonstração em `docs/clinico/05-roteiro-de-demonstracao.md` foi atualizado: dos quatro buracos de percurso listados, três estão fechados.

Este documento é gerado a partir de `docs/clinico/relatorio/Relatorio-Novidades-Modulo-Clinico.html`. O HTML é a fonte; o PDF é a saída.